

Einführung des Patientenportals "CareConnect"

I. Kurzfassung

Das Krankenhaus XY plant die Einführung des Patientenportals "CareConnect" zur Verbesserung der Patientenkommunikation und administrativen Prozesse. Die digitale Lösung soll Terminmanagement, präoperative Anamnese und Arzt-Patient-Kommunikation optimieren. Nach der Auswahl von CareConnect wird die zeitnahe Projektinitiierung empfohlen. Eine ROI-Berechnung ist nicht vorgesehen.

II. Situationsanalyse

Das Krankenhaus XY benötigt eine Modernisierung seiner Dienstleistungen. Manuelle administrative Prozesse wie Anamnese und Terminverwaltung sind ineffizient. Die aktuelle Patientenkommunikation über Papier und Telefon ist fehleranfällig, und es fehlt ein digitaler Zugang zu Behandlungsdaten. Die Digitalisierung soll diese Probleme lösen und die Qualität sowie Patientenzufriedenheit steigern.

SWOT-Analyse:

• Stärken (Strengths):

- Vorhandene IT-Infrastruktur (KIS, RIS, LIS, PACS) mit einem Kommunikationsserver (Mirth Connect) als Basis für die Integration.
- Klare Zielsetzung der Krankenhausleitung, die Digitalisierung voranzutreiben.
- Bereits getroffene Auswahl und Vereinbarung mit dem Softwareanbieter für "CareConnect".

• Schwächen (Weaknesses):

- Aktuell manuelle und zeitaufwändige administrative Prozesse.
- Fehlende digitale Schnittstelle für Patienten zur Datenverwaltung und Kommunikation.
- Mögliche Akzeptanzhürden bei nicht technikaffinen Patienten und Mitarbeitern.

• Chancen (Opportunities):

- Steigerung der Patientenzufriedenheit durch verbesserte Services und Transparenz.
- Effizienzsteigerung und Entlastung des Personals durch digitale Prozesse.
- Positionierung als modernes und patientenorientiertes Krankenhaus.
- Verbesserung der Datenqualität und -verfügbarkeit.

• Risiken (Threats):

- Integrationsschwierigkeiten der neuen Software in die bestehende IT-Landschaft.
- Datenschutz- und Datensicherheitsbedenken (DSGVO-Konformität muss sichergestellt sein).

- Widerstand gegen Veränderungen bei Mitarbeitern.
- Unterschätzung des Schulungsaufwands für Personal und Patienten.
- Änderungen gesetzlicher Vorgaben während des Projekts.

III. Geschäftszweck

Hauptziel des Projekts ist die erfolgreiche Einführung des Patientenportals "CareConnect" im Krankenhaus XY. Damit sollen folgende Zwecke erreicht werden:

- **Verbesserung der Patientenkommunikation und -interaktion:**
 - **Qualitativ:** Stärkere Einbindung der Patienten in ihren Behandlungsprozess, erhöhte Transparenz, verbesserter Informationsfluss.
 - **Quantitativ:** Reduzierung von telefonischen Anfragen zum Terminstatus um 30% innerhalb von 12 Monaten nach Go-Live.
- **Optimierung administrativer Prozesse:**
 - **Qualitativ:** Entlastung des Personals von repetitiven Aufgaben, Reduktion von Medienbrüchen.
 - **Quantitativ:** Reduzierung der Bearbeitungszeit für präoperative Anamnesen um 20% in den ersten 3 Monaten und um 40% innerhalb der ersten 6 Monate nach Einführung. Teilautomatisierung des Terminmanagements.
- **Steigerung der Patientenzufriedenheit:**
 - **Qualitativ:** Modernes Serviceangebot, Gefühl der besseren Betreuung.
 - **Quantitativ:** Erreichen einer Zufriedenheitsrate mit dem Portal von über 80% (gemessen durch Umfragen) 6 Monate nach Einführung. Aktive Nutzung durch mindestens 40% der Patienten im ersten Jahr.
- **Sicherstellung der DSGVO-Konformität und Datensicherheit:**
 - **Qualitativ:** Vertrauen der Patienten in den sicheren Umgang mit ihren Daten.
 - **Quantitativ:** Erfolgreiches DSGVO-Audit und regelmäßige erfolgreiche Sicherheits- und Penetrationstests (Details siehe Projektauftrag).

a. Lösungsoptionen:

Die Software "CareConnect" wurde bereits in mehreren Auswahlstufen als die passende Lösung identifiziert, und es wurde ein Agreement mit dem Anbieter getroffen. Daher konzentriert sich dieser Business Case auf die erfolgreiche Implementierung dieser spezifischen Lösung. Alternative Lösungen werden nicht weiter betrachtet.

b. Nutzen:

- **Für Patienten:**
 - Einfacher und sicherer Zugriff auf Teile ihrer medizinischen Daten und Termine.
 - Möglichkeit zur digitalen Durchführung der präoperativen Anamnese.
 - Direkte und nachvollziehbare Kommunikationskanäle mit dem medizinischen Personal.
 - Aktive Teilnahme am Behandlungsprozess.

- **Für das Krankenhauspersonal:**

- Reduzierung des administrativen Aufwands.
- Effizientere Terminplanung und -verwaltung.
- Verbesserte und dokumentierte Kommunikation mit Patienten.
- Reduktion von Fehlerquellen durch digitale Prozesse.

- **Für das Krankenhaus:**

- Stärkung des Rufs als modernes, patientenorientiertes Gesundheitszentrum.
- Langfristige Kosteneinsparungen durch Prozessoptimierung und Reduktion von manuellem Aufwand und Papier.
- Verbesserte Ressourcennutzung.
- Erfüllung steigender Erwartungen der Patienten an digitale Services.

Die Kosten-Nutzen-Analyse entfällt.

IV. Marktbeurteilung

Der Markt für Patientenportale wächst durch die steigende Nachfrage nach digitalen Gesundheitsdiensten. Als früher Anbieter kann das Krankenhaus XY eine regionale Vorreiterrolle einnehmen. Die Integration muss dabei Interoperabilitätsstandards und DSGVO beachten, während IT-Systemfragmentierung und Nutzerakzeptanz zentrale Herausforderungen darstellen.

V. Risikobewertung

Der Projektauftrag identifiziert bereits eine Reihe von Projektrisiken und entsprechenden Gegenmaßnahmen. Diese werden hier zusammengefasst und bewertet:

Risiko	Eintrittswahrscheinlichkeit	Auswirkung	Gegenmaßnahmen (Auswahl)
Qualitätsrisiken			
Unzureichende Tests	Mittel	Hoch	Umfassender Testplan, Integrationstests, ggf. Einbindung externer Experten.
Mangelhafte Schulung	Mittel	Hoch	Entwicklung benutzerfreundlicher und barrierefreier Schulungsmaterialien (durch Hersteller), Schulung von Key-Usern (Multiplier-Effekt), mehrphasige Schulung.
Technische Risiken			
Integrationsschwierigkeiten	Hoch	Hoch	Detaillierte Analyse der IT-Infrastruktur, klare Schnittstellendefinition, Pilotphase.

Sicherheitslücken	Mittel	Sehr Hoch	Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen nach ISO 31000, regelmäßige Sicherheits- und Penetrationstests durch externe Experten, Datenschutzkonzept.
Auslastungsrisiken			
Überlastung IT-Abteilung	Hoch	Mittel	Einbindung externer Dienstleister/Hersteller, klare Priorisierung und Ressourcenplanung, regelmäßige Abstimmung im Projektteam.
Fehlende Zeit Key-User	Mittel	Mittel	Wertschätzung und Freistellung der Key-User für Projektaufgaben sicherstellen, flexible Schulungszeiten.
Terminrisiken			
Verzögerungen im Projekt	Mittel	Mittel	Detaillierter Projektplan mit Puffern, klare Meilensteine, Statusupdates, Eskalationspfade definieren.
Akzeptanzrisiken			
Widerstand Mitarbeiter/Pat.	Mittel	Hoch	Aktives Change-Management, Informationsveranstaltungen, Einbeziehung der Stakeholder, Supportangebote, barrierefreie und intuitive Gestaltung des Portals.
Geringe Nutzung	Mittel	Hoch	Siehe oben, zusätzlich Marketing für das Portal, Aufzeigen der Vorteile.
Weitere Risiken			
Gesetzesänderungen	Gering	Mittel	Einbindung von Datenschutzexperten, regelmäßige Überprüfung rechtlicher Änderungen.
Unvorhergesehene Kosten	Mittel	Mittel	Budgetpuffer einplanen, regelmäßige Plan-Ist Kontrolle.

VI. Empfehlung

Die Einführung des Patientenportals "CareConnect" wird dringend empfohlen. Die analysierten Prozessherausforderungen und der Wunsch nach Patientenzentrierung sprechen klar dafür. Die

vorausgewählte Software reduziert den initialen Aufwand. Die erwarteten Vorteile - Effizienzsteigerung, Kostensenkung, bessere Patientenkommunikation und strategische Positionierung - überwiegen die Risiken. Erfolgsentscheidend sind sorgfältiges Projektmanagement, Change-Management und Stakeholder-Einbindung. Nächste Schritte: Detailplanung, Teambildung und Start der Analysephase.

VII. Rahmenplan (Grobe Planung auf Monatsbasis, rein fiktiv)

Projektstart: August 2025

Geschätzte Projektdauer: 15 Monate (bis Oktober 2026 für Übergabe an Wartung)

1. Analyse & Vorbereitung (Aug–Nov 25)

- **Bestandsaufnahme IT & Prozesse:** Aug–Sep
- **Anforderungskatalog erstellen:** Okt–Nov
- **Datenschutzkonzept erstellen:** Okt–Nov

Lead: Projektmanager

2. Planung & Konzeption (Okt 25–Mai 26)

- **Integrationsplan:** Dez–Jan
- **KPIs definieren:** Dez
- **Testplan erstellen:** Feb
- **Schulungsmaterial (Basis):** Feb–Mrz

Lead: Projektmanager

3. Technische Integration & Tests (Mrz–Mai 26)

- **Anbindung an KIS, RIS, LIS, PACS:** Mrz–Apr
- **Integrations- & Sicherheitstests:** Mai–Jun

Lead: IT, Hersteller

4. Pilotphase & Schulung (Feb–Aug 26)

- **Schulung Key-User:** Feb–Mrz
- **Pilot-Test (Einführung):** Aug (Meilenstein M1)
- **Feedback & Anpassungen:** Sep

Lead: Projektmanager

5. Rollout & Einführung (Mai–Okt 26)

- **Schulung medizinisches Personal:** Mai–Jul
- **Go-Live:** Sep (Meilenstein M2)
- **Produktiver Betrieb in allen Abteilungen:** Okt

Lead: Projektmanager

6. Evaluierung & Übergabe (Okt 26)

- **Nutzerfeedback & Analyse:** Okt
- **Abschlussbericht:** Okt
- **Übergabe an Wartung:** Okt (Meilenstein M3)

Lead: Projektmanager, IT

Meilensteine (M):

- **M1 (Ende August 2026):** Erfolgreicher Start Pilotbetrieb, technische Funktionalität gegeben.
- **M2 (Ende September 2026):** Go-Live in allen relevanten Abteilungen abgeschlossen.
- **M3 (Ende Oktober 2026):** Projekt erfolgreich abgeschlossen, System an Wartung übergeben, Abschlussbericht liegt vor.

VIII. Umfang & Abhängigkeiten

Projektumfang (In-Scope):

- Integration des Patientenportals "CareConnect" in die bestehende IT-Infrastruktur (KIS, RIS, LIS, PACS via Kommunikationsserver).
- Bereitstellung der Funktionen: präoperative Anamnese, Terminmanagement, Ärzte-Patienten Kommunikation, Feedbackmöglichkeiten.
- Sicherstellung der DSGVO-Konformität.
- Erstellung von Schulungsmaterial für Mitarbeiter und Patienten.
- Durchführung von Schulungen für Mitarbeiter (insb. Key-User) und IT-Abteilung.
- Aktives Change-Management zur Förderung der Akzeptanz.

Nicht im Projektumfang (Out-of-Scope):

- Entwicklung der Software "CareConnect" selbst.
- Integration in externe Systeme wie z.B. die elektronische Gesundheitsakte (ELGA), falls nicht explizit anders vereinbart.
- Langfristige Wartung und Updates (diese gehen nach Projektende in den Regelbetrieb über).
- Entwicklung von Erweiterungen oder komplett neuen Funktionen, die über den initialen Leistungsumfang von CareConnect hinausgehen.

Wesentliche Abhängigkeiten:

1. **Verfügbarkeit und Kooperation der internen IT-Abteilung:** Die Integration erfordert signifikante Ressourcen und Expertise von der internen IT. Engpässe hier können das gesamte Projekt verzögern.
2. **Mitwirkung des Softwareherstellers "CareConnect":** Support, technische Expertise und ggf. Anpassungen seitens des Herstellers sind entscheidend für eine reibungslose

Implementierung und Problembehebung.

3. **Bereitschaft und Verfügbarkeit der Key-User und Fachabteilungen:** Für Anforderungserhebung, Tests, Schulungsvorbereitung und als Multiplikatoren ist die aktive Teilnahme der zukünftigen Hauptnutzer unerlässlich.

IX. Projektorganisation

- **Projektauftraggeber:** Krankenhaus XY
- Projektleiter
- **Projektlenkungsausschuss:**
 - Vertreter der Geschäftsführung
 - Leitung IT-Abteilung
 - Pflegedienstleitung
 - Ärztlicher Direktor (oder ein Vertreter)
 - Projektleiter (berichtet an den Ausschuss)
- **Projektteam (Kernteam):**
 - Projektleiter
 - Teilprojektleiter IT
 - Vertreter des Softwareherstellers "CareConnect"
 - Key-User aus relevanten Fachbereichen (z.B. Patientenaufnahme, Ambulanzen, Stationen)
 - Datenschutzbeauftragter (beratend)
- Projektmanager Kunde
- Externe Berater (für Sicherheitstests, ggf. Datenschutz)

X. Projektberichterstattung

Die Projektberichterstattung dient der transparenten Darstellung des Projektfortschritts, der frühzeitigen Identifikation von Abweichungen und der Steuerung des Projekts.

Erwartungen an Fortschrittsberichte während des Projekts:

- **Frequenz:**
 - Wöchentliche Kurzüpdates im Kernteam.
 - Zweiwöchentliche Statusberichte vom Projektleiter an den Projektlenkungsausschuss.
 - Monatliche ausführliche Projektstatusmeetings mit dem Lenkungsausschuss.
- **Inhalte der Berichte (an Lenkungsausschuss):**
 - Aktueller Status der Arbeitspakete (Ampelsystem: grün, gelb, rot).
 - Erreichte Ziele seit dem letzten Bericht.

- Nächste geplante Schritte und Ziele.
- Aktuelle Risiken und Probleme (inkl. vorgeschlagener Maßnahmen).
- Ressourcenauslastung (grob).
- Budgetentwicklung (grob, falls Budgetrahmen definiert wurde und verfolgt wird – entfällt hier mangels Daten).
- Entscheidungsbedarf.
- **Medium:** Schriftliche Berichte (standardisierte Vorlage), Präsentationen in Meetings.
- **Verantwortung:** Projektleiter.

Informationen/Messgrößen zur Überprüfung nach der Umsetzung (Zielerreichung):

Diese basieren auf den im Projektauftrag und Geschäftszweck definierten Zielen und KPIs:

- **Integration des Patientenportals:**
 - Erfolgsquote der Anbindung an KIS, RIS, LIS, PACS (Systemtests, Protokolle).
 - Funktionstest: Datenanzeige aus angebundenen Systemen im Portal.
- **Schulung und Akzeptanz Mitarbeiter:**
 - Anzahl durchgeführter Schulungsworkshops.
 - Schulungsbeteiligung der Key-User (mind. 90%).
 - Feedback der Mitarbeiter zur Qualität der Schulungen und des Portals.
- **Optimierung interner Prozesse:**
 - Messung der Bearbeitungszeit präoperativer Anamnesen (Vergleich vor/nach Einführung, Ziel: -20% nach 3 Mon., -40% nach 6 Mon.).
 - Analyse des Automatisierungsgrades im Terminmanagement und Feedbackprozess.
- **Datenschutz und Sicherheitsstandards:**
 - Vorlage des Datenschutzkonzeptes und des DSGVO-Auditberichts.
 - Protokolle der durchgeführten Sicherheits- und Penetrationstests (Anzahl und Ergebnisse).
- **Steigerung der Patientenzufriedenheit:**
 - Ergebnisse von Patientenbefragungen zur Zufriedenheit mit dem Portal (Ziel: >80% nach 6 Mon.).
 - Analyse der allgemeinen Patientenzufriedenheit (falls Vergleichswerte vorhanden).
 - Aktive Nutzungsrate des Portals durch Patienten (Ziel: mind. 40% im ersten Jahr, Trendanalyse).

Diese Messgrößen werden in regelmäßigen Abständen nach dem Go-Live (z.B. nach 3, 6 und 12 Monaten) erhoben und bewertet, um den Projekterfolg zu quantifizieren und ggf.

Nachsteuerungsmaßnahmen einzuleiten.